

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA

Centro Materno-Infantil (sintético) — Hospitalización Obstétrica

FILIACIÓN

Nombre:	PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad:	22 años
Estado civil:	Conviviente
Ocupación:	Estudiante
Fecha de ingreso:	02/05/2026

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G2 P1 (parto vaginal 2022, sin complicaciones). Antecedente de anemia leve en gestación previa, no completó tratamiento. Dieta referida pobre en hierro hemínico.

GESTACIÓN ACTUAL

FUM:	01/10/2025
FPP:	08/07/2026
EG actual (por FUM):	30 semanas
Motivo de ingreso:	Anemia severa sintomática
Controles prenatales:	4 al momento

Paciente refiere cefalea persistente, palpitaciones de esfuerzo y fatiga severa en últimas 2 semanas. Tolerancia disminuida a actividad cotidiana. Niega sangrado vaginal, melena o hematuria. Movimientos fetales presentes.

EXAMEN FÍSICO AL INGRESO

PA 100/60 mmHg. FC 108 lpm (taquicardia compensatoria). T° 36.5°C. Peso 58.0 kg. Palidez cutáneo-mucosa marcada. AU 28 cm. LCF 150 lpm. Auscultación cardíaca: soplo sistólico funcional grado 2/6 en foco aórtico. Sin signos de sobrecarga ni edema.

LABORATORIOS (02/05/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	7.2	g/dL	Anemia severa
Hematocrito	22.0	%	Severamente bajo
VCM	72	fL	Microcitosis
HCM	23	pg	Hipocromía
Ferritina	8	ng/mL	Depleción severa de hierro
Saturación transferrina	10	%	Baja
Reticulocitos	1.2	%	Respuesta insuficiente

PLAN

1. Hierro endovenoso (hierro sacarosa o carboximaltosa) según disponibilidad y protocolo institucional. 2. Estudios complementarios: hemograma seriado, función renal, frotis de sangre periférica, perfil de hierro completo. 3. Reevaluación de necesidad de transfusión si Hb persiste <7 g/dL pese a hierro EV o si aparecen signos de descompensación cardiovascular. 4. Monitoreo fetal: NST diario + eco con Doppler arteria cerebral media para descartar anemia fetal. 5. Educación nutricional + suplementación oral combinada al alta. 6. Interconsulta con hematología si etiología no se confirma como ferropénica.